Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 24ª Vara Cível da Capital

Avenida Desembargador Guerra Barreto - Fórum do Recife, S/N, Ilha Joana Bezerra, RECIFE - PE - CEP: 50080-900 - F: (81) 31810223

Processo nº 0005330-52.2023.8.17.4001

AUTOR(A): R. E. D. A. W., ISLA ANDREA DE ANDRADE MELO, EDUARDO ALFREDO DA SILVEIRA WANDERLEY

RÉU: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA, MOUNT HERMON ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, HOSPITAL ESPERANCA LTDA.

S E N T E N Ç A

Vistos etc.,

RYAN EDUARDO DE ANDRADE WANDERLEY, menor impúbere representado pelos seus genitores, todos qualificados na peça vestibular, por intermédio de advogado, ajuizou a presente *ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência* contra **HOSPITAL ESPERANÇA S/A, AMPLA PLANOS DE SAÚDE LTDA E MOUNT HERMON – ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA**, todos qualificados.

Narrou, na inicial, em essência, que é beneficiário de plano de saúde coletivo por adesão operado pela segunda ré e contratado por intermédio da administradora de benefícios requerida (terceira demandada), de matrícula nº 130260017288050, Plano "Ampla Joy AD QC NAC", código do plano nº 491236225, com vigência iniciada em 16/08/2023, e que, no dia 27/10/2023, foi encaminhado para a emergência do primeiro demandado, com recomendação posterior de internação em UTI, o que não foi autorizado pelas segunda e terceira rés, por cumprimento do prazo de carência.

Pugnou, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, que seja a parte ré compelida à autorização e ao custeio do tratamento médico necessário ao restabelecimento de menor postulante. Ao fim, requereu a confirmação da tutela antecipatória e condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Juntou documentos. Requereu a concessão da gratuidade da justiça.

Deferida a gratuidade e concedida a antecipação de tutela, foi determinada a citação (ID 149745224).

Citado, o Hospital Esperança apresentou contestação (ID 152352513), na qual arguiu, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva e a revogação da gratuidade conferida ao autor. No mérito, aduziu que houve negativa do plano de saúde para cobertura do procedimento solicitado pela parte autora, de modo que exigiu o pagamento do valor do serviço para disponibilização da UTI, o que não foi cumprido pelo suplicante. Por fim, pugnou pela inexistência de danos morais indenizáveis e pela total improcedência da pretensão autoral. Acostou documentos.

Ofertada contestação pela ré Ampla – Planos de Saúde LTDA (ID 152893891), na qual defendeu a existência de prazo de carência contratual expressamente previsto de 21 dias úteis para o caso da parte autora, porquanto não indicada a urgência na internação ou laudo expressado pelo médico responsável. Ao final, arguiu sobre a inexistência de prática de ato ilícito, da necessidade de observância do princípio do *pacta sunt servanda* e, por fim, pugnou pela total improcedência da demanda. Juntou documentos.

Anexada, ainda, a contestação da corré Mount Hermon – Administradora de Benefícios LTDA, na qual suscitou preliminar de ilegitimidade passiva para a causa e, no mérito, asseverou que não detém atribuição de autorizar o procedimento de saúde solicitado e que não subsiste o pleito indenizatório em face da contestante, já que não praticou ato ilícito em desfavor da parte autora. Anexou documentos.

Réplica (ID 166595125).

Intimadas para provas, apenas a corré Mount Hermon requereu o depoimento pessoal da parte autora (ID 170884575).

É o relatório. DECIDO.

De chofre, importa destacar que o feito comporta julgamento antecipado, visto que a matéria de mérito, embora de fato e de direito, dispensa a produção de prova em audiência, *ex vi* do disposto no art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Ademais, não há que se falar em depoimento pessoal da parte autora, menor impúbere, tampouco de seus representantes legais, já que apresentados todos os fundamentos iniciais da lide na peça vestibular.

Todavia, antes da análise do mérito, premente o enfrentamento das preambulares de ilegitimidade passiva e impugnação à gratuidade da justiça suscitadas pelas rés.

Inicialmente, cuido em indeferir a prefacial de impugnação à gratuidade judiciária conferida ao autor, uma vez que se trata de menor impúbere, destituído de qualquer vínculo laboral, bem como em razão da ausência de demonstração da suficiência econômica dos autores, ônus que incumbia à impugnante.

Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. PROVA DA CAPACIDADE DO BENEFICIÁRIO. ÔNUS DO IMPUGNANTE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 7 E 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, apreciando as peculiaridades fáticas da causa, deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 2. Além disso, na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu a parte ora agravante, segundo assentado pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1023791 SP 2016/0304627-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2017)

Dessa forma, ausente a comprovação da capacidade financeira da parte autora apta a desconstituir o estado de pobreza inicialmente verificado, deve ser rechaçada a preliminar.

Do mesmo modo, tenho que razão não assiste aos réus Hospital Esperança e Mount Hermon – Administradora de Benefícios quanto às preliminares de ilegitimidade passiva *ad causam*, já que, de acordo com a teoria da asserção, devem ser mantidos no polo passivo da lide aqueles indicados pela parte autora como responsáveis para cumprimento da obrigação pretendida, bem como os que deram causa ou se responsabilizaram pelos eventos narrados na exordial.

Ademais, considerando a aplicação do CDC ao caso em comento, devem ser mantidos no vértice passivo da lide todos aqueles integrantes da cadeia de fornecimento do produto ou serviço, conforme dicção do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º.

Por pertinência:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELA RECORRENTE. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA QUANTO À INTERNAÇÃO DA AUTORA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA RELATADA PELA SOLICITAÇÃO MÉDICA QUE PREVALECE. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO CONSOANTE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Inexistem dúvidas de que os hospitais e clínicas, bem como os demais estabelecimentos de saúde, assim como as operadoras de plano de saúde, são prestadores de serviços, restando sua responsabilidade, desse modo, regrada pelo Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva da parte ré. 2. Em situação de excepcionalidade, dado o caráter de urgência e emergência, é devida a cobertura integral da internação não autorizada pelo plano de saúde. 3. Há nexo de causalidade entre o ato ilícito, que consistiu na não autorização da internação na UTI, e o dano moral experimentado, razão pela qual resta configurado o dever de indenizar. 4. In casu, observando os parâmetros assegurados por esta Corte de Justiça em casos semelhantes, relativo a tratamento de saúde em caso de urgência, há de ser mantida a importância indenizatória fixada na sentença, a ser rateada entre os três sucessores. 5. Precedentes do TJRN (AC nº 0808424-08.2017.8.20.5001, Rel. Desembargador Ibanez Monteiro, 2ª Câmara Cível, j. 01/05/2020; AC nº 2018.011328-5, Rel. Desembargador Amílcar Maia, 3ª Câmara Cível, j. 09/07/2019 e AC nº 2017.016932-0, Rel. Juiz

Convocado Luiz Alberto Dantas Filho, 2ª Câmara Cível, j. 19/02/2019). 6. Apelo conhecido e desprovido. (TJ-RN - AC: 08257565620158205001, Relator: VIRGILIO FERNANDES DE MACEDO JUNIOR, Data de Julgamento: 20/04/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 25/04/2023).

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE INTERNADO COM COVID-19. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. HOSPITAL QUE FAZ PARTE DA CADEIA DE CONSUMO DO SERVIÇO DE SAÚDE. COBRANÇA DE CAUÇÃO PARA INTERNAÇÃO EM UTI. MEDIDA DESPROPORCIONAL E ILEGAL, FACE ÀS PECULIARIDADES DO CONTEXTO PANDÊMICO. SERVIÇO ESSENCIAL AO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ARBITRAMENTO DA CONDENAÇÃO ADEQUADA AO CASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (TJ-AM - RI: 06293809620218040001 Manaus, Relator: Etelvina Lobo Braga, Data de Julgamento: 15/03/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ADMINISTRADORA E OPERADORA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA. CARÊNCIA AFASTADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MANTIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, nos termos da Súmula 608 do STJ, que sedimentou o seguinte entendimento: ?Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão?. 2. A administradora do plano saúde é parte legítima para responder em demanda que objetiva a indenização, em razão de recusa de procedimento. O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade solidária daqueles que de algum modo participam da cadeia de produção e fornecimento do serviço. 3. O período de carência dos planos de saúde legalmente estipulado para hipóteses de urgência ou emergência, conforme disposto no artigo 12, inciso V, alínea ?c?, da Lei nº 9.656/1998, é de no máximo 24 horas. 4. Não é cabível a negativa de cobertura com fundamento no prazo de carência, quando comprovada a urgência ou emergência da internação do paciente. 5. A recusa de plano de saúde da autorização de tratamento, quando fundada em interpretação de cláusula contratual, não configura, por si só, ato ilícito capaz de ensejar danos morais. 6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelo parcialmente provido. (TJ-DF 07312365620208070001 1613664, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 14/09/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/09/2022).

Por isso, **rejeito** as preliminares de ilegitimidade passiva *ad causam*.

Superadas as questões processuais, **passo ao exame do mérito.**

Conforme se observa do presente encadernado, pretende a parte demandante obter autorização do plano de saúde demandado para a realização de tratamento de urgência em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a condenação dos suplicados ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$30.000,00, em razão da negativa de cobertura de atendimento médico.

As empresas rés, por sua vez, asseveram, em substância, que o usuário do plano de saúde réu não cumpriu o prazo de carência previsto no contrato para o caso de procedimento eletivo, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade ou abusividade na negativa de cobertura contratual para o tratamento descrito nos autos. Já o nosocômio acionado aduziu que houve a negativa do plano de saúde para cobertura do procedimento solicitado pela parte autora, de modo que não lhe restou outra opção senão a de promover a cobrança dos custos do aludido tratamento, o que não foi atendido pelo suplicante.

Pois bem.

Dispõe o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90), norma geral, que são nulas as cláusulas abusivas que violem princípios nele esculpidos, assegurando direitos de forma genérica, mas já os incorporando ao contrato.

Já a Lei n° 9.656/98, norma específica que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, positivou o que é considerado legalmente abusivo de forma mais precisa, consolidando o que já era abusivo segundo o CDC, e, portanto, já incorporado ao contrato. A edição deste diploma legal, impôs uma nova leitura do artigo do Código Brasileiro do Consumidor que trata sobre a nulidade de cláusula que coloque o consumidor em posição de desvantagem exagerada, posto que positivou o que deve ser considerado como iníquo, abusivo, que provoque desvantagem exagerada ao consumidor e o que é incompatível com a boa-fé ou com a equidade.

Eis o que reza o artigo 51, IV, do CDC: " *São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV - Estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade; (...)"*

E a desvantagem exagerada, neste caso, pode ter seu conceito extraído do parágrafo primeiro do mesmo dispositivo, que diz ser exagerada a desvantagem que "*restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou desequilíbrio contratual*".

Outrossim, destaco que, em se tratando de ajuste que regula relação de consumo, onde as cláusulas devem ser interpretadas da maneira mais favorável à parte hipossuficiente da relação (art. 47, CDC), a cobertura é devida.

De outro flanco, a natureza do contrato celebrado entre as partes assegura a cobertura de todo e qualquer tratamento de saúde de que venha a necessitar o segurado, ressalvadas as hipóteses de exclusão expressa ou excepcionais que configurem desequilíbrio contratual evidente.

In casu, compulsando os autos, observo restar demonstrada a adesão a seguro saúde pela parte demandante junto à seguradora ré, na modalidade coletivo empresarial, em data de 10/08/2023 (ID 153273491).

Outrossim, devidamente demonstrado o caráter de urgência do tratamento do qual necessitou o autor aos 27/10/2023, visto que diagnosticado como portador de bronquiolite viral aguda, CID 10: J21, conforme laudo de ID 149728698, sendo recomendada a internação em UTI, dada a idade do postulante e as chances de piora de seu quadro clínico.

Destarte, **induvidosa a situação de urgência** vivenciada pelo paciente, ora demandante, como atestou o próprio médico assistente, o que elide a necessidade de observância ao período de carência contratual, que não o prazo de 24h estabelecido na Lei de 9.656/98.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ANEURISMA. PERÍODO DE CARÊNCIA. SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. LIMITAÇÃO NO PRAZO DE INTERNAÇÃO. Os planos privados de assistência à saúde estão submetidos ao regramento da Lei nº 9.656/98, que estabelece, em seu artigo 35-C, a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência. Na hipótese de internação de emergência, necessária para a preservação da vida e integridade física do segurado, devido ao risco de morte ou de lesões irreparáveis, caracterizado nos relatórios médicos e exames, aplica-se o prazo máximo de carência de vinte e quatro horas, previsto no artigo 12, V, c, da Lei 9.656/98. Deve ser garantido o direito à vida e à saúde em detrimento do prazo de carência, considerando-se o diagnóstico de aneurisma cerebral, com intervenção cirúrgica de emergência e posterior internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). (TJ-DF 07152276920188070007 DF 0715227-69.2018.8.07.0007, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 19/06/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. Sentença de parcial procedência, para determinar às rés a cobertura da internação e de todos e quaisquer procedimentos médicos de que tenha precisado ou ainda precise a autora por causa do fato que substancia a demanda. RECURSO DA RÉ NOTRE DAME. Preliminar de ausência de interesse de agir da autora para a propositura da demanda afastada. Operadora que confirmou, em todas as manifestações, a negativa da internação em razão de prazo de carência. Elementos dos autos que também apontam nesse sentido. Mérito. Insurgência que não prospera. Incontroversa a necessidade de internação em caráter emergencial, constante expressamente dos relatórios médicos e não impugnado de forma específica pela operadora. É abusiva a negativa de cobertura em atendimento de urgência e/ou emergência a pretexto de que está em curso período de carência que não seja o prazo de 24 horas estabelecido na Lei n. 9.656/98. Inteligência das Súmulas 597 do STJ e 103 deste Tribunal. Limitação da internação hospitalar em 12 horas de atendimento que também se revela abusiva. Aplicabilidade da Súmula 302 do STJ. Precedentes. RECURSO DA AUTORA. Acolhimento parcial. A recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, de autorizar tratamento médico emergencial enseja reparação a título de danos morais, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano moral in re ipsa. Entendimento do STJ nesse sentido. Fixação em R$ 10.000,00, em observância às peculiaridades do caso e aos precedentes desta Câmara. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ NOTRE DAME. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO." (v. 40696). (TJ-SP - AC: 10000046820228260545 SP 1000004-68.2022.8.26.0545, Relator: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 25/11/2022, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2022).

E ainda que não fosse esse o caso, infiro que a cláusula do prazo de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde não prevalece quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento necessário em caso de emergência ou de urgência.

Em reforço, colho o seguinte julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DA RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA FINANCEIRA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR À CONSUMIDORA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA (ABORTO ESPONTÂNEO "RETIDO") – DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. (Omissis) 2. Prazo de carência (180 dias) estipulado pelo plano de saúde para cobertura de procedimentos cirúrgicos. 2.1. ***A jurisprudência do STJ é no sentido de que "lídima a cláusula de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde, merecendo temperamento, todavia, a sua aplicação quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida"*** *(REsp 466.667/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 27.11.2007, DJ 17.12.2007). 2.2. Incidência da Súmula 283/STF à espécie, pois não refutado o fundamento do acórdão estadual no sentido de que cumprido o prazo de carência estipulado no contrato. (Omissis) (STJ, AgRg no AREsp 624092 / SP, Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 31/03/2015).* (grifei).

Por tudo isso, não se sustenta a restrição imposta pela parte ré, de modo que é presente o dever de custear o tratamento de saúde recomendado ao autor.

Ressalte-se que, **quando a seguradora ré deixa de cobrir o tratamento de saúde de usuário nos termos requisitados pelo profissional médico que o acompanha, restringe direito fundamental inerente à natureza do contrato**, o qual deve ser regido, apenas, pela real necessidade do paciente diante do acometimento de doença, sendo unicamente indicador da indispensabilidade do tratamento o posicionamento médico.

Quanto ao pedido de indenização por **danos morais**, merece guarida o pleito autoral, isto porque, tendo em vista os recentes julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, perfilho do entendimento de que há direito ao ressarcimento do dano moral oriundo da injusta recusa de cobertura securitária médica, pois esta conduta agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, caracterizado por grave ofensa à dignidade da pessoa humana.

A propósito:

"Quanto aos danos morais, conquanto, geralmente, nos contratos o mero inadimplemento não seja causa para ocorrência de danos morais, entendo que, neste caso, a injusta recusa de cobertura enseja a reparação, pois inegavelmente tal fato gera aflição psicológica e angústia no espírito do segurado, já com saúde tão debilitada (REsp 735.168/RJ, Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11/03/2008).

Todavia, nesse ponto, cuido em ressaltar que a responsabilização pela pretendida indenização apenas deve recair sobre as rés Ampla - Planos de Saúde e a Hermon Administradora de Benefícios Ltda, uma vez que o nosocômio acionado não praticou qualquer ato ilícito capaz de ensejar o dever de indenizar. Como visto, a negativa de autorização para internamento do autor foi perpetrada pela administradora de planos de saúde, de modo que restou ao Hospital Esperança apenas a informação e cobrança do valor relativo ao serviço de internação em UTI pretendido, tudo em razão da negativa da operadora, o que afasta o nexo causal em relação ao hospital demandado.

No tocante à quantificação do dano, considerando as circunstâncias que envolveram o caso, a gravidade da situação pela qual passou a parte autora, à condição econômica da ré e demais balizas da condenação ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais, entendo por arbitrá-la em R$5.000,00 (cinco mil reais), solução que reputo mais justa e equânime para o caso.

Ante o exposto, ratifico a liminar anteriormente deferida e, com fulcro no art. 487, I, CPC, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos iniciais para condenar as rés AMPLA – Planos de Saúde LTDA e Hermon Administradora de Benefícios Ltda a custear e a autorizar a internação em UTI do demandante junto ao Hospital Esperança, conforme requerimento do médico assistente, bem como para condená-las solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescida de juros de mora à base de 1% ao mês e de correção monetária pelos índices da tabela ENCOGE, ambos a partir da presente data.

Vencidas, arcarão ainda com o pagamento das custas processuais e da verba honorária advocatícia, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, art. 85, §2°, CPC.

Inacolho, como visto, a pretensão inaugural relativamente ao codemandado Hospital Esperança LTDA, condenando o demandante ao pagamento dos honorários advocatícios deste, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), cobrança cuja exigibilidade fica suspensa por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita.

Publique-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, arquivem-se.

Recife (PE), 30 de setembro de 2024.

Patrícia Xavier de Figueirêdo Lima

JUÍZA DE DIREITO

Assinado eletronicamente por: PATRICIA XAVIER DE FIGUEIREDO LIMA
30/09/2024 12:44:01
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 183443594

24093012440154800000178949121

IMPRIMIR GERAR PDF